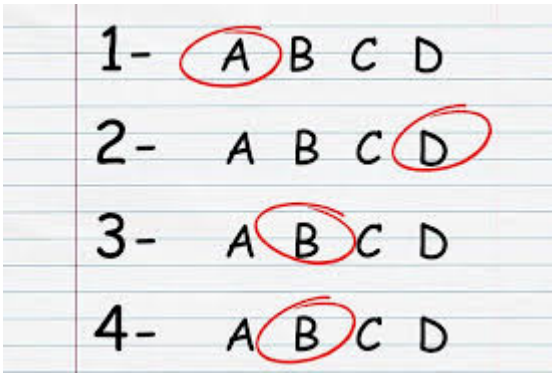


TEMA 32



TEST

DEL

TEMA

LA SALUD PÚBLICA EN LA CIUDAD DE MADRID, MADRID SALUD:

COMPETENCIAS, RED DE CENTROS Y SERVICIOS QUE SE PRESTAN.

PAPEL DEL/LA TRABAJADOR/A SOCIAL EN LAS INTERVENCIONES DE SALUD COMUNITARIA.

1.- Las actividades de salud pública dirigidas al control sanitario del medio ambiente, que incluyen el control de la contaminación del suelo, el agua, el aire ... se incluyen en el ámbito:

a.- De la protección sanitaria.

b.- De la promoción sanitaria.

c.- De la prevención sanitaria.

2.- No entran dentro de los determinantes de la salud:

a.- Los estilos de vida.

b.- El medio ambiente.

c.- Los Servicios Sociales.

3.- Son fundamentos éticos de la Estrategia Salud 21:

a.- La salud es un derecho fundamental de todos los seres humanos.

b.- La participación y responsabilidad de las personas, grupos, instituciones y comunidades en el desarrollo continuo de la salud.

c.- Todas las opciones anteriores son correctas.

4.- ¿En qué artículo de la Constitución se reconoce el derecho a la salud?:

a.- En el artículo 42.

b.- En el artículo 43.

c.- Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

5.- Es competencia exclusiva del Estado (señala la opción incorrecta):

a.- La sanidad y la higiene.

b.- La sanidad exterior.

c.- La legislación farmacéutica.

6.- Los municipios asumen como competencias propias (señala la opción incorrecta):

a.- La sanidad y la higiene.

b.- La protección de la salubridad pública.

c.- Los cementerios y las actividades funerarias.

7.- El Sistema Nacional de Salud está compuesto:

a.- Por el conjunto de servicios sanitarios de la Administración del Estado.

b.- Por el conjunto de servicios sanitarios de la Administración del Estado, junto a los de las Comunidades Autónomas.

c.- Por el conjunto de servicios sanitarios de la Administración del Estado, junto a los de las Comunidades Autónomas y los de las Entidades Locales.

8.- ¿En qué artículo del Estatuto de Autonomía se recoge que la Comunidad de Madrid tiene competencias en materia de sanidad e higiene?:

a.- En el artículo 25.4.

b.- En el artículo 26.4.

c.- En el artículo 27.4.

9.- La Comunidad de Madrid asume como competencias:

a.- La sanidad e higiene.

b.- La coordinación hospitalaria, incluida la de la Seguridad Social.

c.- Ambas opciones son correctas.

10.- ¿En qué año se traspasan los servicios sanitarios del Estado a la Comunidad de Madrid?:

a.- En el año 2.001.

b.- En el año 2.002.

c.- En el año 2.003.

11.- ¿Qué significa "LOSCAM"?:

a.- Ley de Organización Sanitaria de la Comunidad de Madrid.

b.- Ley de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid.

c.- Ley de Orientación Sanitaria de la Comunidad de Madrid.

12.- En la actualidad, "Madrid Salud":

a.- Es un organismo autónomo.

b.- Es una empresa pública.

c.- Es una Dirección General, pero mantiene su antiguo nombre.

13.- Las competencias que son asumidas desde "Madrid Salud" hacen referencia a:

a.- Salud Pública.

b.- Drogodependencias y otros trastornos adictivos.

c.- Ambas opciones son correctas.

14.- En el actual organigrama municipal "Madrid Salud" está ubicada:

a.- En el Área de Gobierno de Políticas Sociales, Familia e Igualdad.

b.- En el Área de Gobierno de Seguridad y Emergencias.

c.- En el Área de Gobierno de Vicealcaldía, Portavoz, Seguridad y Emergencias.

15.- "Madrid Salud" ha publicado Cartas de Servicios relacionadas (señala la opción incorrecta):

a.- La prevención y el control de plagas.

b.- Los festejos taurinos.

c.- Consejo Sanitario en viajes y Vacunación Internacional.

16.- El recurso fundamental de "Madrid Salud", en materia de Salud Pública, son:

a.- Los CMS.

b.- Los CMSc.

c.- Los Centros Sanitarios.

17.- Los CMSc son:

a.- Centros Madrid Salud Comunitaria.

b.- Centros Municipales Salud Climática.

c.- Centros Municipales Salud Comunitaria.

18.- En el ámbito de la protección de la salubridad púbica, no son competencias las relacionadas con:

a.- Salud ambiental y control de vectores y plagas.

b.- Promoción de la salud y bienestar animal.

c.- Trastornos adictivos.

19.- En el ámbito de la "Salud Ambiental" Madrid Salud desarrollar actuaciones destinadas a garantizar:

a.- Las condiciones de salubridad de las viviendas.

b.- La promoción del ejercicio físico.

c.- La prevención de la soledad no deseada.

20.- Podemos definir los Centros Municipales de Salud Comunitaria (señala la opción incorrecta):

a.- Centros municipales especializados en la promoción de la salud.

b.- Centros municipales especializados en la asistencia sanitaria.

c.- Centros municipales especializados en la prevención de las enfermedades.

21.- Los Centros Municipales de Salud Comunitaria actúan:

a.- Abordando los factores económicos relacionados con la salud y la enfermedad.

b.- Abordando los malestares que produce la vida cotidiana.

c.- Abordando la problemática social relacionada con la enfermedad mental.

22.- Dentro de las competencias de Madrid Salud en la promoción de la salud y el bienestar animal, podemos hacer referencia a:

a.- La acogida de animales vagabundos y abandonados.

b.- La esterilización de animales de compañía y el fomento de la adopción.

c.- Ambas opciones son correctas.

23.- Son competencias del Organismo Autónomo Madrid Salud:

a.- La dirección, gestión, supervisión y evaluación de las actividades preventivas, sanitarias y asistenciales de los centros y establecimientos sanitarios de competencia municipal.

b.- El control de la sanidad mortuoria.

c.- Ambas opciones son correctas.

24.- Dentro de las competencias en materia de promoción de la salud y el bienestar animal, no es una competencia municipal:

a.- La acogida de animales vagabundos y abandonados.

b.- El control del matadero municipal.

c.- El Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligros.

25.- El Organismo Autónomo Madrid Salud se compone de dos Institutos Municipales. Señala cual de las siguientes opciones no es correcta:

a.- Instituto de Salud Pública.

b.- Instituto de Adicciones.

c.- Instituto de Prevención y Promoción de la Salud.

26.- El eje fundamental de la atención a los problemas y oportunidades de salud se aborda en la actualidad:

a.- Desde los Centros Municipales de Salud.

b.- Desde los Centros Madrid Salud.

c.- Desde los Centros Municipales de Salud Comunitaria.

27.- Los Centros Municipales de Salud Comunitaria (señala la opción incorrecta):

a.- Son centros municipales especializados en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad.

b.- Su objetivo es tratar la enfermedad.

c.- Se centran en ayudar a personas, grupos y comunidades a conseguir estilos y condiciones de vida saludables.

28.- En los CMSc vamos a encontrar plantillas multidisciplinares con profesionales (señala la opción incorrecta):

a.- De la educación social.

b.- De la ginecología y la psiquiatría.

c.- De la pediatría y la psicología.

29.- Pueden acceder a los CMSc:

a.- La ciudadanía.

b.- Asociaciones y colectivos.

c.- Ambas opciones son correctas.

30.- No es una actuación desarrollada en el ámbito de la prevención de riesgos laborales en el Ayuntamiento de Madrid:

a.- La prestación de los primeros auxilios y los planes de emergencia.

b.- La prevención de la violencia sexual.

c.- La realización de reconocimientos médicos ginecológicos a la mujer.

31.- Para prestar atención a los/as trabajadores/as municipales contamos con:

a.- El Instituto Mariana Pineda.

b.- El Instituto Fabiola de Mora y Aragón.

c.- El Instituto Óscar Romero.

32.- Señala la periodicidad de la Estrategia de Prevención y Promoción de la Salud, Madrid una ciudad saludable:

a.- 2.020-2.023.

b.- 2.021-2.024.

c.- 2.022-2.025.

33.- La Estrategia Madrid, una ciudad saludable se fundamenta en aumentar la capacidad para incrementar el control sobre los determinantes de la salud:

a.- De los órganos municipales.

b.- De las instituciones.

c.- De las personas y comunidades.

34.- La Estrategia Madrid, una ciudad saludable incorpora como líneas de actuación nuevas, en relación a actuaciones anteriores, relacionadas con:

a.- La prevención del suicidio.

b.- La alimentación sana.

c.- La prevención de la soledad no deseada.

35.- La visión propuesta en la Estrategia Madrid, una ciudad saludable es:

a.- Promover una ciudad en la cual las personas mantengan un alto nivel de salud y bienestar potenciando su participación y corresponsabilidad en la consecución de esta situación.

b.- Establecer una relación sólida con las redes sociales del distrito para la salud y cohesión de los barrios y ser proactivos para afrontar momentos de crisis sanitarias.

c.- Ser una red de centros de referencia y liderazgo en la promoción de espacios de encuentro y coordinación intersectorial en salud.

36.- Son principios rectores de la Estrategia Madrid, una ciudad saludable:

a.- El enfoque de género.

b.- El enfoque de infancia.

c.- El enfoque ecológico.

37.- El principio de la Estrategia Madrid, una ciudad saludable por el cual se priorizan las actuaciones en los territorios y colectivos más vulnerables, sin dejar de atender a la población en general, se denomina:

a.- Equidad en salud.

b.- Universalismo proporcional.

c.- Intersectorialidad.

38.- Son criterios metodológicos recogidos en la Estrategia Madrid, una ciudad saludable (señala la opción incorrecta):

a.- Orientación individualizada.

b.- Atención a los determinantes sociales de la salud.

c.- Enfoque salutogénico.

39.- El registro que permite marcar los espacios en un entorno que se significan como fuentes de bienestar para la vida cotidiana, se denomina:

a.- Registro de activos en salud.

b.- Mapeo de activos en salud.

c.- Censo de activos en salud.

40.- Son objetivos generales de la Estrategia Madrid, una ciudad saludable:

a.- Contribuir a promover la salud de la población madrileña y la prevención de sus principales problemas de salud desde la detección precoz, la intervención individual, grupal y el desarrollo de la salud comunitaria.

b.- Promover y sensibilizar sobre la presencia de la salud como un factor relevante a tener en cuenta en las políticas municipales y aportar su perspectiva en aquellos foros, comisiones o grupos de trabajo en dónde esté integrada.

c.- Ambas opciones son correctas.

41.- Son objetivos operativos de la Estrategia Madrid, una ciudad saludable (señala la opción incorrecta):

a.- Promocionar la salud mental y el bienestar emocional en la ciudad de Madrid.

b.- Disminuir la prevalencia y fomentar el abandono de sustancias tóxicas.

c.- Apoyar a la comunidad escolar educativa en las actuaciones de prevención y promoción y de la salud desde un enfoque integral y positivo.

42.- No es un programa transversal dentro de la Estrategia Madrid, una ciudad saludable:

a.- El programa de alimentación y actividad física.

b.- El programa de desigualdades sociales en salud.

c.- El programa de promoción de la salud mental.

43.- Son programas de la Estrategia Madrid, una ciudad saludable orientados a áreas concretas de salud:

a.- El programa de prevención del tabaquismo.

b.- El programa de salud sexual y reproductiva.

c.- Ambas opciones son correctas.

44.- Si hablamos del programa "ALAS", nos estamos refiriendo a actuaciones relacionadas con:

a.- Alimentación, actividad física y salud.

b.- Salud sexual y reproductiva.

c.- Ambas opciones son falsas.

45.- El principal problema al que trata de hacer frente el Programa Marco de Promoción de la salud en el ámbito educativo es:

a.- Las autolesiones.

b.- El sobrepeso.

c.- El absentismo.

46.- Son objetivos específicos de la orientación en salud pública establecida en la Estrategia Madrid, una ciudad saludable:

a.- Prevenir y romper la cadena de contagio en crisis epidemiológicas.

b.- Atender las necesidades de salud provocadas directa e indirectamente por crisis sanitarias.

c.- Además de las anteriores, mantener la atención a las necesidades existentes en salud habituales en la población.

47.- La ausencia de vínculos personales incrementa los riesgos para:

a.- La salud física de las personas.

b.- La salud psíquica de las personas.

c.- Ambas opciones son correctas.

48.- ¿Qué porcentaje de personas manifiestan sentirse solas siempre, casi siempre o bastantes veces?:

a.- El 10,2%.

b.- El 16,2%.

c.- El 22,2%.

49.- Son objetivos específicos del Proyecto estratégico para la prevención de la soledad no deseada:

a.- Fomentar la capacidad de los Centros de Atención Social Primaria para identificar, impulsar y crear actividades que fomenten el encuentro interpersonal.

b.- Sensibilizar a la ciudadanía en materia de soledad no deseada para promover actitudes empáticas y de corresponsabilidad.

c.- Ambas opciones son correctas.

50.- Para fortalecer la capacidad de las personas de afrontar las situaciones de duelo y crear una red de solidaridad y apoyo hacia las personas que se encuentran en situación de final de vida o han sufrido la pérdida de un ser querido, se ha creado el proyecto de:

a.- Comunidades de duelo.

b.- Comunidades de esperanza.

c.- Comunidades compasivas.

51.- Las condiciones en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan, envejecen o se relacionan, constituyen:

a.- Los determinantes en salud.

b.- Los determinantes sanitarios en salud.

c.- Los determinantes sociales en salud.

52.- Las desigualdades sociales en salud son:

a.- Injustas e inevitables.

b.- Justas y evitables.

c.- Injustas y evitables.

53.- Son objetivos específicos propuestos en el Programa Marco de prevención de las desigualdades sociales en salud (señala la opción incorrecta):

a.- Promover la activación de grupos y colectivos que faciliten la conexión entre personas y la creación de vínculos interpersonales.

b.-Fomentar la participación comunitaria promoviendo el empoderamiento de la ciudadanía.

c.- Fomentar la aplicación de la perspectiva de género en todas las actuaciones.

54.- En relación a los hábitos de vida de la ciudadanía madrileña, son correctos:

a.- La alimentación inadecuada.

b.- La escasa realización de actividad física.

c.- Además de las anteriores, el sedentarismo.

55.- El Programa marco de alimentación, actividad física y salud trata de reducir la prevalencia de:

a.- Enfermedades transmisibles relacionadas con los estilos de vida.

b.- Enfermedades no transmisibles relacionadas con los estilos de vida.

c.- Ambas opciones son correctas.

56.- El Programa marco de alimentación, actividad física y salud, dentro de sus objetivos específicos, trata de reducir la prevalencia de:

a.- Diabetes tipo 2.

b.- Cáncer.

c.- Hipotensión.

57.- El objetivo general del Programa Marco de Salud Sexual y Reproductiva es:

a.- Contribuir a la disminución del retraso del diagnóstico en VIH e ITS.

b.- Informar y facilitar sobre el acceso a los métodos anticonceptivos más adecuados a las necesidades de cada persona.

c.- Contribuir a la vivencia sana y placentera de las diversas sexualidades de las personas en la ciudad de Madrid.

58.- Son objetivos específicos del Programa Marco de Salud Sexual y Reproductiva:

a.- Identificar estrategias de afrontamiento sobre la soledad no deseada en aquellas personas que en su día a día sufren malestares producidos por una mala vivencia relacionadas con la salud sexual y reproductiva.

b.- Sensibilizar sobre la salud sexual y reproductiva con perspectiva de género.

c.- Ambas opciones son correctas.

59.- La población diana del Programa Marco de Salud Sexual y Reproductiva es la población en general, con especial atención:

a.- A la población menor de 25 años.

b.- A la población menor de 30 años.

c.- A la población menor de 35 años.

60.- Dentro de las actuaciones de Madrid Salud se va a desarrollar:

a.- Un programa de prevención y control del consumo de alcohol.

b.- Un programa de prevención y control del consumo de tabaco.

c.- Un programa de prevención y control del consumo de medicamentos.

61.- Se considera población diana del Programa de prevención y control del consumo de tabaco:

a.- A adolescentes en el grupo de edad de inicio en el consumo de tabaco.

b.- A adultos con enfermedades crónicas relacionadas con el consumo de tabaco.

c.- A funcionarios/a del Ayuntamiento de Madrid.

62.- El Programa Marco de Promoción de la Salud Mental tiene entre sus objetivos específicos:

a.- Prevenir la soledad no deseada en todas las edades y fomentar las relaciones basadas en el buen trato, el respeto mutuo, la autonomía y la cooperación.

b.- Ofrecer apoyo y atención psiquiátrica en situaciones de crisis o para personas alejadas de la red de salud mental.

c.- Ambas opciones son correctas.

63.- La población diana del Programa Marco de Promoción de la Salud Mental se considera:

a.- Al conjunto de la población.

b.- A la población que no es atendida en la red de salud mental.

c.- A la población que ha abandonado previamente procesos de atención psiquiátrica.

64.- Dentro del Programa Marco de Salud Materno Infantil se propondrá como objetivo general:

a.- Favorecer el buen trato y la paternidad responsable.

b.- Favorecer maternidades y paternidades positivas que posibiliten el desarrollo adecuado del menor.

c.- Favorecer maternidades y paternidades positivas que eviten el maltrato y el riesgo en niños, niñas y adolescentes.

65.- Son actuaciones desarrolladas dentro del Programa Marco de Promoción de la Salud en el ámbito educativo:

a.- Los desayunos saludables y la prevención del consumo de tabaco.

b.- La salud bucodental y la educación para la afectividad y sexualidades saludables.

c.- Todas las opciones anteriores son correctas.

66.- Según los datos de la Estrategia Madrid Ciudad Saludable, cuantos Centros Municipales de Salud Comunitaria hay en el municipio de Madrid:

a.- 21, uno por distrito.

b.- 16.

c.- 12.

67.- Dentro de Madrid Salud vamos a encontrar 5 centros específicos que actúan en todo el municipio. Señala cuál de las siguientes opciones no corresponde a un centro específico:

a.- Centro de Prevención del Deterioro Cognitivo.

b.- Centro de Salud Sexual y Reproductiva.

c.- Centro Joven.

68.- Entre los Centros de Apoyo con los que cuenta Madrid Salud podemos señalar (señala la opción incorrecta):

a.- Centro de Salud Internacional.

b.- Centro de Diagnóstico por Imagen.

c.- Laboratorio de Análisis Clínicos.

69.- Los denominados "Proyectos de Centro" en Madrid Salud se elaboran teniendo en cuenta:

a.- Las necesidades de la población.

b.- Los recursos sociales, sanitarios y educativos del área de influencia.

c.- Ambas opciones son correctas.

70.- Los inicios del trabajo social en el ámbito sanitario podemos situarlos:

a.- En el año 1.902 en Londres.

b.- En el año 1.905 en Estados Unidos.

c.- En el año 1.914 en Barcelona.

Plantilla de respuestas

1.-	A, p. 3	**6.-**	A, p. 5	**11.-**	B, p. 6
2.-	C, p. 4	**7.-**	B, p. 5	**12.-**	A, p. 8
3.-	C, p. 4	**8.-**	C, p. 6	**13.-**	C, p. 8
4.-	B, p. 5	**9.-**	C, p. 6	**14.-**	C, p. 8
5.-	A, p. 5	**10.-**	A, p. 6	**15.-**	B, p. 11-12

16.-	B, p. 14	**21.-**	B, p. 14	**26.-**	C, p. 14
17.-	C, p. 14	**22.-**	C, p. 13	**27.-**	B, p. 14
18.-	C, p. 12-13	**23.-**	C, p. 9-11	**28.-**	A, p. 14
19.-	A, p. 13	**24.-**	B, p. 13	**29.-**	C, p. 14
20.-	B, p. 14	**25.-**	C, p. 13	**30.-**	B, p. 15

31.-	B, p. 15	**36.-**	C, p. 18	**41.-**	B, p. 20
32.-	B, p. 16	**37.-**	B, p. 17	**42.-**	A, p. 21
33.-	C, p. 16	**38.-**	A, p. 19	**43.-**	C, p. 21
34.-	A, p. 16	**39.-**	B, p. 19	**44.-**	A, p. 22
35.-	A, p. 17	**40.-**	C, p. 19	**45.-**	B, p. 22

46.-	C, p. 23	**51.-**	C, p. 25	**56.-**	A, p. 27
47.-	C, p. 24	**52.-**	C, p. 26	**57.-**	C, p. 28
48.-	A, p. 24	**53.-**	A, p. 25	**58.-**	C, p. 29
49.-	B, p. 24	**54.-**	C, p. 27	**59.-**	A, p. 29
50.-	C, p. 25	**55.-**	B, p. 27	**60.-**	B, p. 29

61.-	A, p. 30	**66.-**	B, p. 36
62.-	A, p. 31	**67.-**	B, p. 36
63.-	A, p. 31	**68.-**	A, p. 36
64.-	B, p. 32	**69.-**	C, p. 37
65.-	C, p. 34	**70.-**	B, p. 38